

Entrevista psiquiátrica y examen mental

1. Introducción y relevancia clínica

La **entrevista psiquiátrica** es el instrumento diagnóstico fundamental en psiquiatría.

A diferencia de otras especialidades médicas, el **diagnóstico en salud mental** se basa casi exclusivamente en la **evaluación clínica**, sin exámenes complementarios específicos que confirmen la patología.

Por ello, dominar la entrevista y el **examen mental** es esencial para:

- Obtener información confiable sobre los síntomas actuales y la historia del paciente.
- Evaluar el juicio, la percepción, el pensamiento y la afectividad.
- Distinguir entre enfermedades psiquiátricas, reacciones adaptativas y causas orgánicas.
- Establecer una **alianza terapéutica**, clave para la adherencia al tratamiento.

□ En el **EUNACOM**, este tema es evaluado en preguntas de caso donde se solicita identificar alteraciones del pensamiento, afecto o juicio, y en ECOE mediante simulación de entrevista o interpretación del examen mental.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La psiquiatría moderna reconoce que los trastornos mentales surgen de la **interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales** (modelo biopsicosocial).

Por ello, la entrevista psiquiátrica no solo explora los **síntomas**, sino también el **contexto vital** y la **estructura de personalidad** del paciente.

2.1. Bases de la entrevista psiquiátrica

La entrevista busca comprender tres dimensiones:

1. **Lo que el paciente dice (contenido):** síntomas, historia, experiencias.
2. **Cómo lo dice (forma):** coherencia, afecto, lenguaje, contacto.

3. **Lo que el médico observa (conducta y expresión):** elementos no verbales que pueden revelar psicopatología.

2.2. Rol del médico

El clínico debe mantener una actitud:

- Empática y no enjuiciadora.
- Directiva pero flexible.
- Capaz de crear un **clima de confianza** sin perder objetividad.

El objetivo no es solo “recoger datos”, sino **entender el significado subjetivo de la experiencia del paciente**.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

La entrevista psiquiátrica consta de **tres etapas** y culmina con el **examen mental estructurado**, que funciona como el “examen físico” del psiquiatra.

3.1. Estructura de la entrevista

1. Etapa inicial: establecer rapport

- Presentación y explicación del propósito de la entrevista.
- Garantizar confidencialidad.
- Lenguaje adaptado al nivel del paciente.
- Observación inicial de la conducta, vestimenta, higiene, postura, contacto visual y cooperación.

2. Etapa intermedia: exploración clínica

Se obtiene la **historia psiquiátrica completa**, que incluye:

- **Motivo de consulta y enfermedad actual.**

- **Historia psiquiátrica previa:** diagnósticos, tratamientos, hospitalizaciones.
- **Historia médica general:** enfermedades neurológicas, endocrinas o infecciosas.
- **Historia familiar:** antecedentes de trastornos psiquiátricos o suicidio.
- **Historia personal y social:** infancia, escolaridad, trabajo, relaciones, consumo de sustancias.

3. Etapa final: cierre

- Resumen de lo expresado.
- Clarificación de dudas.
- Evaluar riesgo suicida o de daño a terceros.
- Explicar pasos siguientes (tratamiento o derivación).

3.2. Examen mental (EM)

El **Examen Mental (EM)** es una descripción sistemática del estado actual del paciente en los dominios de **apariencia, conducta, afecto, pensamiento y cognición**.

I. Apariencia general y conducta

- Vestimenta, aseo, postura.
- Actitud hacia el entrevistador: colaborador, hostil, evasivo.
- Nivel de actividad psicomotora: inhibición, agitación, tics, estereotipias.

II. Lenguaje

- **Cantidad:** verborrético, mutista, lacónico.
- **Ritmo:** acelerado, lento, pausado.
- **Coherencia y articulación:** bloqueos, tangencialidad, incoherencia.

III. Estado de ánimo y afecto

- **Ánimo (subjetivo):** cómo se siente el paciente (triste, ansioso, eufórico).
- **Afecto (objetivo):** cómo lo percibe el examinador.
 - Lábil: cambios rápidos.
 - Plano: sin expresión emocional.
 - Incongruente: no coincide con el relato.

IV. Pensamiento

- **Curso:** fuga de ideas, pensamiento retardado, bloqueo.
- **Forma:** disgregado, tangencial, incoherente.
- **Contenido:** ideas delirantes, obsesivas, de culpa o ruina.
- **Percepciones anormales:** alucinaciones, ilusiones.

V. Sensopercepción

- **Alucinaciones auditivas:** comunes en esquizofrenia.
- **Visuales:** frecuentes en intoxicaciones o delirium.
- **Cenestésicas, olfativas o táctiles:** menos comunes, pero sugerentes de organicidad.

VI. Juicio e insight

- **Juicio:** capacidad de valorar consecuencias de los actos.
- **Insight:** conciencia del propio estado patológico (puede ser nulo, parcial o completo).

VII. Funciones cognitivas

- **Orientación:** en tiempo, espacio y persona.
- **Memoria:** inmediata, reciente y remota.
- **Atención y concentración:** meses del año al revés, series de 7 en 7.

- **Abstracción:** interpretación de refranes.
 - **Mini-Mental Test:** útil para tamizaje de deterioro cognitivo.
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Aunque el diagnóstico en psiquiatría es **clínico**, algunos exámenes ayudan a descartar causas orgánicas o guiar el manejo:

4.1. Laboratorio básico

- Hemograma, glicemia, función hepática y renal.
- TSH y T4 libre (descartar hipotiroidismo o hipertiroidismo).
- Serología VDRL, VIH, B12, ácido fólico.
- Test de drogas en orina.

4.2. Neuroimágenes

- TAC o RM cerebral: en sospecha de tumor, TEC, hidrocefalia o deterioro cognitivo rápido.

4.3. Evaluaciones específicas

- **Mini-Mental Test (Folstein):** screening de demencia.
 - **Escala GDS (Geriatric Depression Scale):** depresión en adultos mayores.
 - **Escala Hamilton o Beck:** severidad depresiva.
 - **Escala PANSS:** síntomas psicóticos.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

Aunque la entrevista y el EM son principalmente diagnósticos, forman parte del **manejo integral del paciente psiquiátrico**, ya que:

- Facilitan la **psicoeducación** y el **vínculo terapéutico**.
- Permiten detectar riesgo suicida, consumo de sustancias y necesidad de hospitalización.

5.1. En atención primaria (APS)

- **Primera entrevista estructurada**, registro en ficha clínica.
- Si se identifica riesgo vital (suicida, heteroagresivo, confusional): derivar de urgencia.
- Si se diagnostica patología leve-moderada (ansiedad, depresión leve): iniciar manejo en APS.
- Utilizar instrumentos GES: **Escala de Depresión de Beck**, **MINI entrevista estructurada**.

5.2. Derivación a nivel secundario

- Psicosis, ideación suicida, síntomas maníacos, deterioro cognitivo progresivo, fracaso terapéutico.
- En hospitales generales, el **equipo de interconsulta psiquiátrica** realiza reevaluación diagnóstica y ajuste de tratamiento.

6. Complicaciones y pronóstico

El **error diagnóstico** o una **entrevista incompleta** puede llevar a:

- Tratar con antidepresivos a pacientes con trastorno bipolar (empeora el cuadro).
- No identificar riesgo suicida o delirios peligrosos.
- Omitir causas orgánicas (encefalopatías, hipotiroidismo, intoxicaciones).

Cuando la entrevista es completa y se establece una buena alianza terapéutica:

- Aumenta la **adherencia al tratamiento**.
- Disminuye la **tasa de reconsulta y recaídas**.

- Mejora la detección temprana de comorbilidades.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. La entrevista psiquiátrica debe ser **estructurada pero flexible**, adaptada al paciente.
 2. La **hematuria del psiquiatra es el pensamiento alterado**: siempre describir curso, forma y contenido.
 3. El **afecto plano** es típico de esquizofrenia; el **lábil**, de trastornos afectivos.
 4. La **incongruencia afectiva** es un hallazgo clave en psicosis.
 5. El **insight nulo** predice mal pronóstico y mala adherencia.
 6. En adultos mayores, **realizar siempre Mini-Mental y descartar causas orgánicas**.
 7. **Preguntar directamente por ideación suicida**: no aumenta el riesgo, mejora la pesquisa.
-



Errores comunes

- Omitir antecedentes médicos o farmacológicos (p. ej., corticoides, que pueden inducir manía).
- No explorar consumo de sustancias.
- No evaluar riesgo suicida por temor a “sugerirlo”.
- Confundir afecto plano con tristeza.
- No registrar el examen mental en la ficha clínica.

- Diagnosticar depresión sin descartar hipotiroidismo o duelo reciente.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **entrevista psiquiátrica** es la herramienta diagnóstica central, orientada al modelo biopsicosocial.
2. El **examen mental** evalúa apariencia, conducta, afecto, pensamiento, percepción, juicio e insight.
3. Toda **hematuria mental (alteración del pensamiento)** debe describirse en forma, curso y contenido.
4. Siempre **descartar causas orgánicas** y realizar exámenes básicos de laboratorio y neuroimagen si es necesario.
5. Evaluar **riesgo suicida y de agresión** en todo paciente.
6. La **alianza terapéutica** es un factor pronóstico positivo esencial.
7. En atención primaria, registrar y derivar según severidad o riesgo vital.